

إِسْم الْمَرِيضِ رُبَاعِيًّا : عمرو محمد عيد على

المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : البدرشين

رقم البطاقة : 26802092100119 رقم التلفون : 01122237567 تاريخ تسجيل الإستمارة : 10-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 09-02-1968 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان المثانة البولي

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان المثانة البولية

خطة العلاج : أورام كيمائي بروتوكول علاج كيمائي خط ثاني للورم المنتشر
(Platinum +Gemcitabine) [14245]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

التوقيع: 

التوقيع:

التوقيع: (مستند رقم ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠)

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / 2 ----- / 2 ----- / 2.1 ----- / 2.1

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج :-

ملاحظات : ---

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: عمرو محمد عيد علي National ID: 26802092100119	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

A patient of bladder cancer for Platinum plus gemcitabine chemotherapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار: 2025-6-2

جبهه الاصدار: فرع الجيزة

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) عمرو محمد عيد بطاقة رقم 26802092100119

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من اللجان الطبيه يفيد ان المواطن غير لائق
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة: 2025-6-2



افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد...



مسلسل 669470

الخطاب ساري لمدة ثلاث اشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو
وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمي



Name: عمرو محمد عيد علي			
MR. : 8383			
Detailed Medical Report			
		السيد	
تجبة طبية وبعد,,			
إيماء للطلب المقدم من		بشأن تقرير طبي للمريض	
بقسم:		رقم طبي:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
58 year-old male, smoker, with diabetes mellitus, hypertension, and ischemic heart disease complicated by dilated cardiomyopathy with an ejection fraction of 40 %. He underwent transurethral resection of bladder tumor (TURBT) in May 2025 for a high-grade papillary urothelial carcinoma that was focal and non-muscle invasive. Imaging in May 2025 revealed a large infiltrative bladder mass, regional lymphadenopathy, and bilateral pleural effusion. Subsequent staging CT and PET were planned, along with pathology review, laboratory work-up, echocardiography, and multidisciplinary team discussion for treatment planning. On 23 February 2026, CT demonstrated bilateral pulmonary nodules (right lower lobe 6.2 × 5 mm) and mediastinal lymphadenopathy. The bladder mass measured 8 × 5.2 cm with an exophytic component obstructing both ureters, causing moderate to marked hydroureter and hydronephrosis (right 8.4 cm, left 3 × 2.2 cm). The patient was referred for stent or nephrostomy placement, and an ICU referral was made due to his cardiomyopathy. Hemoglobin was 5.4 g/dL, prompting consideration of blood transfusion. On 11 June 2026, hemoglobin rose to 6.8 g/dL after transfusion; a repeat CBC was ordered and nephrostomy placement was pending. On 13 June 2026, hemoglobin was 8.4 g/dL. The patient received gemcitabine 1500 mg (10 % dose reduction) on cycle 1 day 1 as a single agent until nephrostomy placement and new kidney function assessment, after which carboplatin would be considered. On 20 June 2026, the patient had bilateral marked hydronephrosis. Nephrostomy was still pending; gemcitabine 1500 mg was postponed until after nephrostomy and repeat creatinine (2.9 mg/dL) was obtained. On 11 July 2026, the plan was to administer gemcitabine on cycle 2 day 8, with bilateral nephrostomy scheduled for the following day and a follow-up appointment for the patient. On 25 July 2026, the patient had bilateral double J stents placed. Hemoglobin was 7 g/dL and a blood transfusion was given. New ultrasound and follow-up creatinine/creatinine were noted, with creatinine 3 mg/dL. On 26 July 2026, hemoglobin was 8 g/dL and the patient received gemcitabine 1500 mg on cycle 3 day 1. New labs were ordered to assess CBC and creatinine next week. Bilateral mild hydronephrosis and hydroureter were noted, with hepatic flares; new CT imaging was planned after this cycle. On 15 August 2026, serum creatinine was 2.6 mg/dL, giving a creatinine clearance of 30 mL/min, precluding cisplatin. A CT of the chest, abdomen, and pelvis was pending, as was a urine culture. The patient complained of dysuria and pain; pain control was initiated. Gemcitabine was planned for cycle 4			
تحريرا في ,			
التاريخ :		20-09-2026	
الوقت :			
الطبيب المعالج :		dina makram	
يعتمد ,			

day 1 as a single agent, with other labs accepted.

On 31 August 2026, CT performed on 15 August 2026 showed the bladder mass now measuring 10×7.3 cm, inseparable from the prostate (previously 8×5.2 cm). Multiple bilateral hepatic focal lesions were noted, largest 6.4×5.2 cm. New para-aortic, bilateral common, internal, and external iliac lymph nodes were identified, largest 4×3 cm, not seen on the 2 February 2026 CT. The case was discussed at MDT for further management.

On 12 September 2026, MDT recommended using the 8 August 2026 CT as baseline, continuing gemcitabine for two additional cycles, then performing a CT of the chest, abdomen, and pelvis for evaluation. Palliative radiotherapy to the bladder was considered if bleeding occurred. The patient was scheduled for cycle 5 day 1 gemcitabine; platelet count was $728 \times 10^9/L$, hemoglobin 8.4 g/dL, and total leukocyte count $10.17 \times 10^9/L$ for follow-up.

The patient has completed 5 cycles of gemzar.

EL Azamia Lab

Prof. Abdalla Khalil
Pathology Lab



معمل الأعظمية

أ. د. عبدالله خليل
للتحاليل الباثولوجية

Patient Name : عمرو محمد عيد على

Age : 57 Y

Nature of the Specimen : Resection Biopsy

Clinical Diagnosis : Urinary Bladder Mass Invading The Wall And Prostatic Tissue

Receiving Date : 18/05/2025

Code Number : 41910 

PATHOLOGY REPORT

GROSS PATHOLOGY:

Multiple rubbery gray tan and pink tissue pieces measured collectively 4.5x4.5 cm, totally submitted.

HISTOLOGY:

Microscopic examination revealed fragments of bladder mucosa with malignant growth formed of papillary structures lined by multiple layers of markedly anaplastic urothelial cells with pleomorphic nuclei, the tumor focally infiltrating lamia propria and cores.
No muscle propria to asses it's invasion.

DIAGNOSIS:

Papillary Urothelial Carcinoma, High Grade Focally Infiltrating Core And Lamina Propria;
Focally Necrotic.
No Muscle Bundles Proper To Asses Staging.

P.O.:

2 Slides enclosed.

Prof. Dr. Laila Moussa, PhD

Laila Moussa

Prof. Dr. Badawia Bayoumi, PhD

Badawia Bayoumi

Prof. Dr. Samira Abdallah, MD

Samira Abdallah

أذن في ملف
أ. د. عبد الله خليل